



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض رابعياً : ساميه طه ابراهيم عبداللطيف

العنوان : ..

المحافظة : الفيوم الحي / المدينة : طاميه

رقم البطاقة : 29010152303402 رقم التليفون : 01116825200 تاريخ تسجيل الإستمارة : 27-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 15-10-1990 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : اورام ليمفاويه

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : اورام ليمفاويه

خطة العلاج : أورام كيماوي علاج تدعيمي وتلطيفي [6396] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ساميه طه ابراهيم عبداللطيف National ID: 29010152303402	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

A patient of lymphoma for Supportive and palliative care with follow-up

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



سمايه
طه ابراهيم عبد اللطيف
فاتوس
مركز طامية - الفيوم

١٩٩٠/١/١٥

٢٩.١.١٥٢٣.٣٤.٢

KD5262147



٢٠٢٣/٠٨

٢٩.١.١٥٢٣.٣٤.٢

ربة منزل



متزوجة

معلمة

أنش

عوض سيد زكى احمد

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٨/٢٢



Patient Name	: الأستاذ / سامية طه ابراهيم	Request No.	: 13005215
Patient No.	: 29010152303402	Request Date	: 26/02/2026
Path No.	: 557/26	Verification Date	: 08/03/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 35 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Addendum Report.

Clinical Data: Multiple large pathological lymph nodes within the right axilla, extending deep to the right pectoralis muscle, likely lymphoma.

Nature of Specimen: Right axillary lymph node (Tru cut biopsy), collected on 26/2/2026, at 12:00 pm.

Gross Examination:

- Two grey white tissue cores measuring 0.5 and 1.2 cm, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for; CD20 clone (L26), CD3 clone , Ki67 (30-9), CD30 (Ber-H2), CD15 (MMA), CD4 (SP35), CD8 (SP57), CD56 (MRQ-42), CD5 (SP19) & CD7 (SP94).

Microscopic Examination:

- Histopathological examination reveals nodal tissue showing effacement of architecture & replacement by infiltrate formed of mainly lymphoid T-cells (CD3 Positive). The infiltrate is diffuse with focal nodular pattern.

* IPT Results (Positive control showed appropriate reactivity):

- CD20: Showed scattered few cells.
- CD3: Positive many T-cells.
- Ki67%: 40%.
- CD15: Negative.
- CD30: Negative.
- CD4: Diffusely positive.
- CD7: Diffusely positive.
- CD8: Positive in many T-cells.
- CD56: Negative.
- CD5: Negative.

Verified by :

Dr.Heba Hasan



Name: ساميه طه ابراهيم عبداللطيف		
MR. : 9663		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient was diagnosed with peripheral T-cell lymphoma based on clinical examination of a right axillary lymph node; further work-up was ordered including CT of the neck and chest-abdomen-pelvis (CAP), virology studies, and an echocardiogram. A PET scan was requested but subsequently rejected; the plan was to proceed with a CT CAP and initiate CHOEP chemotherapy. The patient began the first cycle of CHOPE for peripheral T-cell lymphoma after laboratory results and an echocardiogram performed on 26 April 2026 showed an ejection fraction of 61 %. Imaging on 30 April 2026 demonstrated right axillary lymph nodes measuring 5.2 × 3.3 cm, a small right hilar lymph node 9 mm × 7 mm, and several focal splenic lesions. Chemotherapy was continued with cycle 2 of CHEOP, which had been delayed due to a "qarar" issue. The patient received the fourth cycle of CHOP-E; a PET-CT performed after three cycles showed a right axillary node now measuring 3 cm with SUV 29 and splenic foci measuring 5 × 3 cm with SUV 17. The patient was scheduled to receive CHOP-E today after laboratory results obtained on 18 August 2026 were acceptable.		
تحريرا في ,		
	التاريخ : 21-09-2026	الوقت :
هاجر حمدي عبدالهادي محمود		الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذة / سامية طه إبراهيم

Patient No. : 29010152303402

Path No. : 557/26

Sex : Female

Age : 35 Y

Referring Doc :

Request No. : 13005215

Request Date : 26/02/2026

Verification Date : 08/03/2026

Financial Category : جوستاف روسي - مبادره

Department : Out Patient

Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Diagnosis:

Right axillary lymph node, Tru-cut biopsy;

Findings are compatible with peripheral T-cell lymphoma.

Signature

Prof. Dr.Gamal Abdel Aty

Dr.Heba El-Shafeey

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 05/04/2026 10:04:34

Page 2 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss



Right breast sonomammography

Right breast

- No nipple retraction or areolar thickening.
- Normal thickness of the subcutaneous layer.
- Retroareolar ductal ectasia.
- Fibroglandular breast parenchyma with more thickening of its upper lateral aspect; however, no solid or cystic mass formation within.
- No micro- or macro-calcifications.

Right axilla

- Multiple large lymph nodes within the right axilla, extending deep to the right pectoralis muscles; the largest lymph nodes = 4cm, 3.6cm, 2.2cm, and 2cm; They show distorted hila with hyperemic changes.



Conclusion

- Fibroadenosis of the right breast showing retroareolar ductal ectasia; however, no sign of malignancy within.
- Multiple large pathological lymph nodes within the right axilla, extending deep to the right pectoralis muscles, likely Lymphoma.
- Core needle biopsies are recommended for histopathological correlation.

Dr./Emad Hafim Elaba

Name : Samia Taha Ibrahim

Date : 03-02-2026 10:45

Branch : Mamm

Medical No. : 312076

Ref.Physician Prof : Goussay Roussey Egypt

Ins.Company : Walkin

BILATERAL MAMMOGRAM AND BREAST ULTRASONOGRAPHY REVEALED:

Indication: Right axillary lump.

- Breast density: Scattered densities of glandular tissue . Breast density matches ACR B.
- No detected suspicious mass density, architectural distortion or pathological micro-calcification.
- Multiple dense large right axillary distorted shape LNs.
- Normal skin and nipple.

By complementary breast ultrasound:

- Homogeneous (predominantly fatty) back ground parenchymal echo-texture.
- No detected suspicious solid or cystic masses in both breasts.
- Mildly dilated retro-areolar ducts bilaterally with clear contents . Normal skin and nipple bilaterally.
- Multiple (more than 5 in number) suspicious looking levels 1,2 and 3 right axillary LNs, the largest measures (5.5 x 3 cm).
- No detected significant left axillary LNs on both sides.

CONCLUSION:

- Right breast : Heavy pathological axillary affection with no detected breast masses ,for pathological correlation (BI-RADS 4 Category).
- Left breast : Normal study (BI-RADS 1 Category).

Prof.MONA ZAKY